·消化内镜学分会 30 周年专栏·

超声内镜引导下胃肠吻合术进展

吕瑛



吕瑛，南京大学医学院附属鼓楼医院消化科副主任，主任医师。中华医学会消化内镜学分会超声内镜学组副组长、中华医学会消化病学分会胰腺病学组委员、中华医学会消化病学分会营养支持协作组委员、中国医师协会内镜医师分会内镜健康管理专委会委员、中国抗癌协会肿瘤胰腺病学专业委员会委员、江苏省医学会胰腺病学分会副主任委员、江苏省医学会消化病学分会常务委员、江苏省消化疾病质控中心副主任。

胃流出道梗阻临床表现为恶心、呕吐、进食困难等，患者生活质量明显下降。其病因包含肿瘤导致的恶性胃流出道梗阻，以及消化性溃疡、术后吻合口狭窄等病因导致的良性胃流出道梗阻，既往治疗方式包括外科开腹或腹腔镜下胃肠吻合，以及内镜下置入肠道金属支架，每种治疗方式各具优缺点。而超声内镜引导下的胃肠吻合术（EUS-GE）兼具了高效、微创的优势。

EUS-GE 从最初的设想到应用至临床经历了十余年的历程。EUS-GE 于 2002 年由 Fritscher-Ravens 等首先提出，但因操作繁杂、设备简陋无法应用于临床。直至 2012 年，Binmoeller 等首次在 EUS-GE 中使用了 LAMS 金属支架，2013 年，Ioi 等首次报道了双气囊封堵胃空肠吻合术，这些器械设备的研发简化了步骤，提高了技术成功率，2015 年 EUS-GE 术应用于临床。

随着 EUS-GE 在临床逐步开展，其适应证也进一步扩展，由最初应用于恶性胃流出道梗阻至有明显症状的良性胃流出道梗阻患者、胃外科术后的输入袢综合征患者、胃改道术后合并胆胰疾病的困难 ERCP 患者，随着技术的延伸吻合部位从胃十二指肠、胃空肠逐渐拓展至十二指肠空肠、空肠空肠、结直肠等，解决消化道梗阻的区域越为广泛。

EUS-GE 的术式多样，包括：直接穿刺、逆行穿刺、会师技术、单球囊辅助法、鼻胆管辅助法、双球囊辅助法等，每种技术各有所长，各技术之间的成功率及临床疗效并没有明显差异。选择的术式需要依据操作者具备的技术优势决定，吻合部位之间的距离是影响技术成功的关键因素之一，距离小于 1 cm 成功的几率越大。

目前的临床研究表明，EUS-GE 的技术成功率、临床成功率分别为 92% 和 90%，并发症的发生率为 12%，再干预率为 6%。并发症的发生有出血、支架移位、支架再堵等，我院单中心 104 例 EUS-GE 的经验表明支架移位、支架再堵等并发症基本可以通过内镜解决。EUS-GE 的再干预率明显低于内镜下肠道金属支架的置入，EUS-GE 和外科以及腹腔镜下胃肠吻合术相比，二者之间的临床成功率、技术成功率无明显差异，但在并发症发生率、医疗费用等方面，前者远低于后者。

EUS-GE 是微创、高效的技术，但 EUS-GE 对操作者的技术要求比较高，未来需要研发更多的器械和设备使得技术难度降低，能广泛应用于临床。

DOI：10.3877/cma.j.issn.2095-7157.2022.02.008

作者单位：210008　南京，南京大学医学院附属鼓楼医院消化科

（收稿日期：2021-12-28）

（本文编辑：李祥英）

吕瑛. 超声内镜引导下胃肠吻合术进展[J/CD]. 中华胃肠内镜电子杂志，2022，9(2)：71.